

HealthMatch

Business Plan

Software estratégico de automação operacional para a Coaph — com opção de virar plataforma escalável

Versão	Captação Pre-seed (revisão corporate venture)
Data	Junho / 2026
Estágio	Pré-lançamento — produto funcionalmente pronto
Âncora	Coaph (Fortaleza / Ceará) — investidor-cliente âncora
Tese	Defensiva (economia operacional da Coaph) + ofensiva (escala) — opcional
Ask	R\$ 1,5 milhão — trancado por resultado

Documento confidencial. Empresa em pré-lançamento, sem receita realizada. As projeções de receita do HealthMatch (tese ofensiva) são premissas de mercado (💡). A economia operacional da Coaph (tese defensiva) parte de um custo atual informado (~R\$ 240 mil/mês) e de percentuais a validar no piloto. As duas lentes são separadas e não se somam.

Sumário

1. Sumário executivo.....	3
2. A tese de investimento (defensiva + ofensiva).....	4
3. Business Case para a Coaph.....	5
4. Descrição da plataforma.....	6
5. Análise de mercado.....	7
6. Público-alvo e personas.....	8
7. Produto e funcionalidades.....	9
8. Estratégia de marketing e vendas (Go-to-Market).....	10
9. Estrutura operacional e equipe.....	11
10. Plano financeiro do HealthMatch (tese ofensiva).....	12
11. KPIs do piloto Coaph.....	13
12. Análise SWOT.....	14
13. Riscos e plano de mitigação.....	15
14. Recomendação de investimento.....	16
15. Roadmap e próximos passos.....	17

1. Sumário executivo

HealthMatch é, antes de tudo, um software estratégico de automação operacional para a Coaph — que automatiza a gestão de plantões, escalas, contatos, confirmações e o back-office financeiro hoje feitos à mão. Em segundo plano, é uma plataforma com potencial de escalar para outras cooperativas, hospitais e o setor público.

Hoje a Coaph gasta ~R\$ 240 mil/mês (R\$ 2,88 mi/ano) com prepostos dedicados à gestão manual de plantões. O HealthMatch ataca diretamente esse custo. É isso que sustenta o investimento — não a promessa de escala nacional.

Duas teses, deliberadamente separadas

	Tese defensiva (base da decisão)	Tese ofensiva (upside opcional)
Lógica	Reduzir o custo operacional da própria Coaph	Virar plataforma para outras cooperativas, hospitais e setor público
Métrica	Economia mensal sobre os R\$ 240 mil/mês	Receita recorrente (SaaS) + take-rate (GMV)
Quem ganha	Coaph (como cliente)	HealthMatch (como empresa) e investidores
Papel	Justifica o aporte sozinha	Multiplica o retorno se acontecer

O pior cenário aceitável: o HealthMatch gerar, dentro da Coaph, economia operacional suficiente para pagar o investimento. A 50% de substituição (realista), a economia é de R\$ 120 mil/mês → payback de R\$ 1,5 mi em ~12,5 meses, sem depender de um único cliente externo.

Item	Resumo
Posicionamento	Automação operacional para a Coaph (defensivo) + opção de plataforma escalável (ofensivo)
Custo atacado (Coaph)	~R\$ 240 mil/mês · R\$ 2,88 mi/ano com prepostos/operação manual
Ask	R\$ 1,5 milhão, trancado e condicionado a metas de adoção e economia
Payback (defensivo, realista 50%)	~12,5 meses só com a economia da Coaph
Relação com a Coaph	Investidor-cliente âncora (aporta capital e assina contrato como cliente)
Status do produto	Funcionalmente completo e testado internamente; pronto para o piloto
Upside (ofensivo)	Receita líquida Ano 3 ~R\$ 16,5 mi (realista) se a escala externa acontecer

Enquadramento honesto: para um investidor financeiro puro, o HealthMatch ainda é cedo (pré-receita, fundador solo, sem tração externa). Para a Coaph, o investimento pode ser racional mesmo sem escala externa, porque existe uma economia operacional concreta e mensurável de até R\$ 240 mil/mês sendo atacada. A escala externa é upside, não premissa.

2. A tese de investimento (defensiva + ofensiva)

Tese defensiva — eficiência operacional da Coaph (a base). A Coaph mantém prepostos que, manualmente, montam escalas, contatam profissionais, negociam plantões, confirmam presença e conciliam pagamentos — custo de ~R\$ 240 mil/mês. O HealthMatch automatiza grande parte desse fluxo (matching + IA no WhatsApp + confirmações + financeiro). Mesmo que o produto nunca seja vendido a terceiros, ele se justifica se reduzir esse custo o suficiente para pagar o aporte. A defesa do investimento é uma conta de redução de custo, não de receita futura.

Tese ofensiva — plataforma escalável (o upside). A mesma plataforma pode ser oferecida a outras cooperativas, hospitais/redes privadas e ao setor público. Aí o HealthMatch vira uma empresa de SaaS + marketplace, com receita recorrente e take-rate sobre o GMV. Esse cenário transforma o aporte da Coaph em participação numa empresa de tecnologia — mas é opcional para a decisão.

Regra de decisão: a Coaph investe pela tese defensiva e trata a ofensiva como bônus. Se a escala não vier, o capital já terá sido justificado pela economia interna. Se vier, o retorno se multiplica.

3. Business Case para a Coaph

Premissas: custo atual R\$ 240 mil/mês com prepostos; investimento R\$ 1,5 mi. Esta análise é a economia da Coaph — não é receita do HealthMatch (ver §10) e as duas não se somam.

Payback da economia operacional

Cenário	Substituição	Econ./mês	Econ./ano	Payback	ROI anual
Conservador	25%	R\$ 60 mil	R\$ 720 mil	~25 m	48%
Realista	50%	R\$ 120 mil	R\$ 1,44 mi	~12,5 m	96%
Otimista	75%	R\$ 180 mil	R\$ 2,16 mi	~8,3 m	144%
Teto teórico	100%	R\$ 240 mil	R\$ 2,88 mi	~6,3 m	192%

- 25% é a base conservadora de defesa; 50% a realista; 75% a otimista.
- 100% não deve ser premissa — exigiria eliminar toda a operação manual e redesenhar processos, o que raramente ocorre.
- Mesmo no conservador (25%), o investimento se paga em ~2 anos apenas com a economia interna, antes de qualquer real de receita externa.

Condição para a economia se materializar: automatizar tarefas não basta — é preciso redesenhar o processo (realocar/reduzir prepostos, eliminar retrabalho). Por isso o piloto tem metas de redução de horas/custo, não só de uso do sistema (ver §11 e §13).

4. Descrição da plataforma

Missão: garantir que toda unidade de saúde tenha o profissional certo no plantão certo — com agilidade, conformidade e custo justo.

Visão: ser a camada de inteligência operacional do trabalho em saúde no Brasil.

Proposta de valor

Para quem	Dor hoje	O que o HealthMatch entrega
Coaph (âncora)	~R\$ 240 mil/mês em prepostos; escala manual; retrabalho	Automação do fluxo de plantões → redução de custo operacional
Outras cooperativas	Mesmo problema, sem tecnologia	Plataforma pronta, white-label
Hospitais / redes privadas	Plantões descobertos, credenciamento manual	Banco de plantonistas, matching com checagem e conflito de agenda
Setor público (SUS/UPAs)	Cobertura difícil, controle de presença	Escala com auditoria e rastreabilidade
Profissionais de saúde	Grupos informais, burocracia	Ofertas compatíveis via WhatsApp, transparência

Capacidades já existentes: matching (especialidade, CBO, credencial, no-show, conflito de agenda); pipeline de vagas; candidaturas → alocações → escala com presença; mensageria omnichannel com agente de IA e handoff humano; financeiro de intermediação com margem; auditoria; RBAC; white-label.

5. Análise de mercado

A análise de mercado embasa a tese ofensiva (upside). A decisão de investimento da Coaph não depende dela.

O Brasil tem ~562 mil médicos ativos (CFM, 2024) e 2,5+ milhões de profissionais de saúde. O preenchimento de plantões é majoritariamente manual (WhatsApp, planilhas, agências, cooperativas com pouca tecnologia).

TAM / SAM / SOM (bottom-up)

◆ $GMV \text{ de plantões} = n^{\circ} \text{ de plantões/ano} \times \text{ticket médio (R\$ 1.300)}$. Receita endereçável $\approx 10\%$ do GMV.

Camada	Definição	GMV/ano	Receita endereçável (≈10%)
TAM	GMV de plantões/escalas de saúde no Brasil	◆ R\$ 15–20 bi	◆ R\$ 1,5–2,0 bi
SAM	Nordeste + cooperativas/hospitais/público	◆ R\$ 3–4 bi	◆ R\$ 300–450 mi
SOM (3–5 anos)	CE + cooperativas adjacentes do NE	◆ R\$ 150–300 mi	◆ R\$ 15–30 mi

Concorrência: o concorrente nº 1 é o processo manual (WhatsApp + planilhas + prepostos) — exatamente o que a tese defensiva ataca. Software hospitalar (Tasy/MV) e gestão de clínicas (iClinic/Feegow) não fazem matching+IA+marketplace de plantão. Comps internacionais (Nomad, Trusted, Medely, Patchwork) validam o modelo, mas não operam no Brasil.

6. Público-alvo e personas

ICP de entrada: a Coaph, como design partner, investidor e primeiro cliente. Expansão (upside): outras cooperativas do NE → hospitais/redes privadas → setor público.

Personas

1. Diretoria da Coaph (decisor econômico): quer reduzir o custo de R\$ 240 mil/mês e ganhar controle/conformidade.
2. Coordenador(a) de escala (usuário-chave): vive apagando incêndio de plantão descoberto.
3. Preposto/operador (parte impactada): tarefas automatizadas — exige gestão de mudança (ver §13).
4. Médico/profissional cooperado (oferta): quer ofertas relevantes via WhatsApp, sem burocracia.

7. Produto e funcionalidades

Stack técnica: NestJS + Prisma + PostgreSQL; Next.js + Tailwind; IA via Anthropic (Haiku); mensageria Twilio/WhatsApp/Meta/Zenvia; Docker. ~20 módulos, API REST padronizada.

Módulos funcionais (testados — 32/32 testes de API, 14/14 regras de negócio)

Módulo	O que faz
Matching	Pontua profissional x vaga, detecta conflito de agenda e elegibilidade
Vagas & Contratos	Pipeline de plantão (avulso, recorrente, cobertura, pool)
Candidaturas → Alocações → Escala	Aprovação gera alocação; controle de presença/no-show
IA conversacional	Aborda e negocia plantões via WhatsApp; handoff humano em ações críticas
Financeiro	Recebíveis, pagáveis, taxa de plataforma e margem
Credenciamento	Conselhos, CBO, RQE, documentos com validade
Auditoria & RBAC	Trilha de mutações; perfis de acesso
White-label	Branding por cliente

Maturidade: MVP construído e testado internamente, pronto para o piloto. Lacunas para escala (roadmap): multi-tenancy robusto, billing/split automatizado, observabilidade, testes de carga, ativação plena da IA.

8. Estratégia de marketing e vendas (Go-to-Market)

Fase 0 — Coaph (mês 0–6): implantar na Coaph como cliente-âncora; piloto com metas de redução de custo operacional (não só de uso). O case vira a principal peça de venda.

Fase 1 — Densidade regional (mês 6–18): outras cooperativas de saúde do NE, via indicação da âncora e eventos do setor cooperativista.

Fase 2 — Novos segmentos (mês 18–36): hospitais/redes privadas do NE; piloto no setor público.

Sobre a base de 55 mil cooperados: é uma vantagem de oferta uma vez operacionalizada — não liquidez automática. A adoção pelos profissionais e o redesenho do processo são pré-condições.

9. Estrutura operacional e equipe

Hoje: fundador solo (bootstrap), produto construído. A rodada (trancheada) financia o time mínimo:

Fase	Contratações	Racional
Imediato (mês 0–3)	1 Eng. sênior · 1 CS/Ops	Hardening + implantação na Coaph
Mês 3–9	+1 Eng. · 1 Comercial	Sustentar a Coaph e abrir cooperativas
Mês 9–18	+1 Eng./Dados · +1 CS	Escala de IA/matching
Contínuo (PJ)	Design, Contábil, Jurídico/LGPD	Custo variável

10. Plano financeiro do HealthMatch (tese ofensiva)

⚠ Esta seção é o cenário de upside (HealthMatch como empresa). A defesa do investimento pela Coaph não depende destes números — ela se sustenta no §3. Não somar a economia da Coaph (§3) à receita aqui.

◆ Premissas: ticket/plantão R\$ 1.300; take-rate 5/7/8%; ARPA SaaS ~R\$ 4.000/mês; margem bruta blended ~68%.

Receita líquida — 3 cenários (SaaS + take-rate)

Cenário	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Conservador	R\$ 0,43 mi	R\$ 2,26 mi	R\$ 6,38 mi
Realista	R\$ 1,09 mi	R\$ 5,99 mi	R\$ 16,5 mi
Otimista	R\$ 1,98 mi	R\$ 11,9 mi	R\$ 33,3 mi

DRE resumida (realista, R\$ mil)

Linha	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Receita líquida	1.090	5.990	16.500
Lucro bruto (~68%)	740	4.073	11.220
Opex total	(1.490)	(3.600)	(8.000)
EBITDA	(750)	+473	+3.220

Métricas SaaS (visão SaaS-only, conservadora): ARPA R\$ 4.000/mês · CAC R\$ 15.000 · churn 12%/ano · LTV/CAC ~7,7× · payback de CAC ~4,7 meses. Break-even ofensivo ~mês 20–22.

Comparação das duas lentes: a tese defensiva (§3) entrega payback em ~12,5 meses (realista) com um único cliente. A tese ofensiva precisa de tração externa para entregar os R\$ 16,5 mi de receita no Ano 3. A primeira é a âncora da decisão; a segunda é o prêmio.

11. KPIs do piloto Coaph

O piloto é desenhado para provar a economia operacional, não apenas o uso do software. Métricas medidas antes (baseline) e depois:

KPI	Como medir	Meta no piloto
Custo mensal com prepostos	Folha + encargos da operação manual	↓ -25% a -50%
Horas manuais eliminadas/mês	Time-tracking da equipe operacional	↓ progressiva
% de plantões preenchidos sem intervenção humana	Logs da plataforma	↑ a cada ciclo
Tempo médio de preenchimento de plantão	Abertura → confirmação	↓ de horas p/ minutos
Taxa de aceite via WhatsApp/IA	Aceites IA ÷ ofertas	Baseline + crescer
% de confirmações automatizadas	Confirmações sem operador	↑
Redução de retrabalho operacional	Reaberturas/correções de escala	↓
Redução de erros de escala	Conflitos/no-shows não detectados	↓
Profissionais ativados	Cadastros ativos	Crescimento
Plantões processados	Volume pela plataforma	Crescimento
NPS dos coordenadores	Pesquisa periódica	≥ alvo acordado
Economia operacional mensal	Estimada × realizada	Gatilho das tranches

12. Análise SWOT

Forças	Fraquezas
• Tese defensiva ataca custo concreto (R\$ 240 mil/mês) • Produto construído e testado, pronto para piloto • Coaph como investidor-cliente âncora alinhado • IA + matching + financeiro num só lugar • Acesso à base de 55k cooperados (via Coaph)	• Fundador solo; sem time formado • Sem receita/tração externa ainda • Forte dependência da Coaph • Economia só se realiza com redesenho de processo • Multi-tenancy/billing ainda a construir
Oportunidades	Ameaças
• Replicar o case para outras cooperativas • Expansão para hospitais e setor público • Sistema cooperativista nacional como esteira • IA reduz custo operacional drasticamente	• Coaph optar por construir/contratar in-house • Resistência interna de prepostos/coordenadores • Economia não se materializar no % esperado • Mudança regulatória (CLT × PJ, LGPD)

13. Riscos e plano de mitigação

Risco	Prob./Imp.	Mitigação
Virar software customizado p/ a Coaph, não startup escalável	Médio/Alto	Arquitetura multi-tenant desde o início; contrato separa licença de investimento; roadmap de produto, não de consultoria
Dependência excessiva da Coaph	Alto/Alto	Abrir 1–2 cooperativas no Ano 1; contrato plurianual; investimento trancado dilui o risco no tempo
Economia não se materializar no % esperado	Médio/Alto	Base conservadora de 25%; piloto com baseline e metas; tranches liberadas só contra economia comprovada
Resistência interna (prepostos, coordenadores)	Médio/Alto	Gestão de mudança; envolver coordenadores como co-desenhadores; comunicar realocação, não só corte
Automação parcial exigir manter equipe humana	Médio/Médio	Implantação por fases; medir horas eliminadas, não uso; metas realistas (25–50%, não 100%)
Substituir tarefas sem reduzir custo real	Médio/Alto	Redesenho operacional explícito no escopo; KPI = economia realizada, não teórica
Regulatório/trabalhista (PJ × CLT)	Médio/Alto	Jurídico especializado; plataforma de gestão da cooperativa, que detém o vínculo
LGPD / dados sensíveis de saúde	Médio/Alto	Compliance desde o início; criptografia, RBAC, DPO
Execução com time pequeno	Médio/Médio	Contratações-chave na Tranche 1; founder foca em produto + Coaph

Princípios de mitigação: piloto com metas objetivas · implantação por fases · KPIs de redução de horas manuais · contrato comercial separado do investimento · tranches condicionadas à economia gerada · comitê mensal Coaph + HealthMatch para acompanhar o ROI.

14. Recomendação de investimento

A Coaph deve investir somente se TODAS as condições abaixo forem atendidas:

5. Assinar contrato como cliente-âncora (licença/serviço), separado do instrumento de investimento.
6. O investimento for trancheado (não desembolso único).
7. A liberação de cada tranche estiver vinculada a metas reais de adoção e economia operacional.
8. Existirem métricas de sucesso claras (os KPIs do §11) e um comitê mensal de acompanhamento.

Estrutura de tranches sugerida (total R\$ 1,5 mi)

Tranche	Valor	Gatilho de liberação	Uso
Tranche 1	R\$ 300–500 mil	Assinatura do contrato + início	Piloto, implantação, hardening, LGPD, integrações
Tranche 2	~R\$ 500 mil	Economia comprovada $\geq$ R\$ 50 mil/mês	Expansão de uso na Coaph; 1as contratações
Tranche 3	~R\$ 600 mil	Economia $\geq$ R\$ 100 mil/mês (ou volume equivalente)	Escala interna + preparo da expansão externa

Por que assim: o trancheamento converte uma aposta de R\$ 1,5 mi num investimento escalonado pelo resultado — a Coaph só compromete capital adicional após ver a economia real. Alinha incentivos, reduz o risco de software de gaveta e mantém o foco em valor mensurável.

15. Roadmap e próximos passos

0–6 meses — Implantação na Coaph (Tranche 1)

- Assinar contrato (cliente) + instrumento de investimento (tranches).
- Hardening (multi-tenancy, billing, LGPD) + integrações.
- Piloto com baseline e metas de economia; comitê mensal de ROI.

6–18 meses — Provar economia e abrir o 2º cliente (Tranches 2–3)

- Atingir $\geq$ R\$ 50 mil/mês e depois $\geq$ R\$ 100 mil/mês de economia.
- Abrir 1–2 cooperativas do NE com o case da Coaph.

18–36 meses — Escala (tese ofensiva)

- Hospitais/redes privadas; piloto no setor público.
- Preparar rodada seed com tração real.

Resumo da decisão: a Coaph investe pela economia operacional (defensiva); a escala externa é upside. Mesmo no cenário conservador (25%), o capital se paga em ~2 anos só com a economia interna.